

方案一：口餵食

照顧者以少量多餐來餵食患者，吃得下就吃，如果會噁到或暫時不想吃，那就不勉強，盡量讓患者覺得吃東西是舒適的。

方案二：鼻胃管灌食

利用細管自鼻子插入經喉嚨到達胃部，此管路用以人工灌食像流質食物或配方奶等食品。

目前的醫學證據（多項高品質研究，包括大型前瞻性隊列及NEJM綜述）顯示，鼻胃管無法降低吸入性肺炎的風險。
鼻胃管無法改變疾病的進程與死亡的過程。



灌食時病人坐高，緩慢灌食。

方式	由口餵食	鼻胃管管灌
優點	1. 患者比較舒適 2. 對食物有味覺，可獲得由口進食的滿足感 3. 保持和家人的互動，與照顧者有好的接觸，不會剝奪社交感 4. 不需約束患者	1. 短期營養支持
風險	1. 餵食時間長，耗費人力 2. 食物準備也需要比較費心與費時，陪伴者需耐心餵食 3. 因疾病進展，容易會有噎咳或吸入性肺炎問題	1. 鼻胃管刺激鼻咽處之不適 2. 可能造成鼻腔黏膜壓瘡 3. 外觀之不適 4. 擔心自拔管路，可能需約束患者

由口餵食：降低嗆咳風險的進食方式

1. 飲食質地調整

- 固體食物：切小塊、煮軟爛、去除骨頭與刺。
- 液體：必要時加入增稠粉(快凝寶)，使其呈現蜂蜜狀或布丁狀，減少嗆咳。
- 避免乾硬、鬆散易掉渣的食物(如花生、餅乾)。
- 溫度適中，避免過熱或過冷刺激。

2. 進食姿勢

- 坐姿挺直，必要時下巴微收(chin tuck)：吞嚥時將下巴輕輕收向胸口，幫助氣道關閉，減少食物流入氣管的風險。
- 進食後保持坐姿 30 分鐘，減少食物逆流回咽喉的風險。
- 用餐環境保持安靜，需要求病人專心進食，避免邊吃邊講話。

3. 進食方式

- 小口慢吃，一次只吞少量。
- 重複吞嚥法(Double Swallow)：同一口食物或液體連續吞兩次，確實吞下後再進下一口。

4. 口腔衛生

- 每餐後刷牙或漱口，清除食物殘渣。
- 假牙每日清潔，保持口腔乾淨，降低肺炎風險。